

Analiza prawna projektu ustawy UD207

o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Wersja 2.0 — po korektach merytoryczno-redakcyjnych (Perplexity v13 + ChatGPT v14)
Analiza projektu UD207 — wersja 4.0 opublikowana 13 maja 2026 r., przyjęta przez Radę Ministrów 12 maja 2026 r.; kontynuacja analizy wcześniejszej wersji z 6 maja 2026 r.

Autor: zespół prawny pakietu obywatelskiego UD207 **Data wersji:** 16 maja 2026 r.
(akceptacja autorska: 18 maja 2026 r.) **Status:** Wersja finalna v2.0 — po dwóch turach niezależnej weryfikacji (Perplexity v13, ChatGPT v14).

ZASTRZEŻENIE

Niniejsza wersja 2.0 zachowuje pełną strukturę analizy prawnej (4 części, 36 zarzutów prawnych). Wprowadzono korekty redakcyjno-merytoryczne wynikające z dwóch tur niezależnej weryfikacji: Perplexity v13 (pobranie pełnego tekstu orzeczeń z baz oficjalnych — sn.pl, trybunal.gov.pl, hudoc.echr.coe.int, curia.europa.eu) oraz ChatGPT v14 (weryfikacja zgodności z aktualnym tekstem projektu UD207 wersja 4.0 z 13.05.2026).

Część I. Niezgodności konstytucyjne i kolizje z aktami prawnymi

Projekt UD207 w wersji 4.0 z 13.05.2026 r. wprowadza do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nowy rozdział 13c regulujący tzw. „praktyki pseudomedyczne”, z sankcjami administracyjnymi sięgającymi 1 000 000 zł oraz uprawnieniami represyjnymi Rzecznika Praw Pacjenta. Analiza wskazuje na liczne, poważne wady konstytucyjne i systemowe, a także na sprzeczność z prawem Unii Europejskiej i Europejską Konwencją Praw Człowieka.

1. Problemy konstytucyjne — zasada określoności prawa (art. 2 Konstytucji RP)

Pojęcie „praktyki pseudomedycznej” zostało zdefiniowane w art. 67zj ust. 1 projektu w sposób oparty na trzech blankietowych pojęciach, z których każde wymaga interpretacji eksperckiej i każde generuje samodzielne wątpliwości konstytucyjne:

- ****„aktualna wiedza medyczna”** — pojęcie dynamiczne, zmieniające się w czasie, zależne od konsensusu naukowego, którego stopień zgodności bywa różny w różnych dziedzinach. Polski Sąd Najwyższy w postanowieniu z 5.06.2019 r., III KK 212/18 (sprawa z art. 160 § 2 k.k. dotycząca błędu diagnostycznego) wskazał, że ocena zgodności postępowania lekarza z „aktualną wiedzą medyczną” wymaga każdorazowego dowodu z opinii biegłych, a niedające się usunąć wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga się in dubio pro reo (art. 5 § 2 k.p.k.). Przeniesienie tego kryterium do art. 67zj UD207 — bez analogicznych gwarancji procesowych — rodzi stan, w

którym podmiot ponosi ciężar obalenia domniemania niezgodności z pojęciem, którego ustalenie sam SN uznał za wymagające ekspertyzy biegłych.

- „**świadczenie zdrowotne**” — pojęcie znane polskiemu prawu medycznemu (ustawa o działalności leczniczej), ale jego użycie jako elementu deliktu administracyjnego zagrożonego karą do 1 mln zł wymaga większej precyzji i wyraźnego rozgraniczenia od działań edukacyjnych, profilaktycznych, dobrostanowych, dietetycznych, religijnych, coachingowych i dziennikarskich.
- „**publiczne rozpowszechnianie**” — pojęcie niedookreślone w epoce mediów społecznościowych; otwarte pozostaje pytanie, czy obejmuje wpisy prywatne, grupy zamknięte, korespondencję, materiały szkoleniowe, wypowiedzi naukowe.

Zgodnie z utrwaloną linią Trybunału Konstytucyjnego (m.in. K 11/94, P 19/06, P 46/13) przepisy represyjne — a takimi są kary administracyjne do 1 mln zł — muszą spełniać podwyższony standard określoności (lex certa). Adresat normy powinien być w stanie z góry przewidzieć, czy jego zachowanie wyczerpuje znamiona deliktu administracyjnego. W obecnym kształcie projekt tego standardu nie spełnia.

2. Prawo do obrony i ciężar dowodu (art. 42 ust. 2, art. 45 Konstytucji RP)

Art. 67zł ust. 4 projektu stanowi, że ciężar udowodnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 (zaprzeszanie praktyki, usunięcie skutków), spoczywa na stronie postępowania. Samo w sobie nie jest to pełne odwrócenie ciężaru dowodu co do wszystkich znamion praktyki pseudomedycznej. Jednak w połączeniu z nieostrością definicji z art. 67zj, rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji oraz odpowiednim stosowaniem art. 64a (w szczególności decyzji tymczasowej z ust. 3, do której nie stosuje się art. 10 i 81 KPA) konstrukcja ta **rodzi poważne ryzyko nierównowagi proceduralnej na niekorzyść strony**, niezgodne z:

- zasadą domniemania niewinności wywiedzioną z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP;
- standardem z art. 6 ust. 2 EKPC, który ETPC stosuje również do postępowań kwalifikowanych jako „criminal” w rozumieniu kryteriów Engela;
- zasadą in dubio pro reo, wyłączaną przez konstrukcję, w której organ nie musi udowodnić wystąpienia deliktu, a obwiniony musi udowodnić jego brak.

Argument ten potwierdza również stanowisko 7 organizacji pracodawców systemu ochrony zdrowia z lipca 2025 r. (Pracodawcy dla Zdrowia, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i in.), które podnosi przerzucenie ciężaru dowodu jako samodzielny, odrębny zarzut konstytucyjny.

Dodatkowo art. 64a projektu ma dwa różne mechanizmy:

- ust. 1–2: publiczne ostrzeżenie / podanie informacji do publicznej wiadomości — w drodze postanowienia, na które służy skarga do sądu administracyjnego;
- ust. 3 (z ust. 4): decyzja tymczasowa o zaniechaniu zachowań z rygorem natychmiastowej wykonalności — do tej decyzji nie stosuje się art. 10 i 81 KPA.

Połączenie tych konstrukcji tworzy proceduralną sytuację, w której strona dowiaduje się o postępowaniu na etapie decyzji wykonanej natychmiast, jednocześnie ponosząc ciężar dowodu negatywnego w zakresie okoliczności egzoneracyjnych.

3. Publikacja decyzji i ostrzeżeń przed prawomocnością — domniemanie niewinności

Projekt przewiduje kilka mechanizmów publikacji informacji o praktykach przed prawomocnością decyzji co do meritum sprawy:

- **art. 47 ust. 1b:** upowszechnianie orzecznictwa przez publikację decyzji RPP na stronie internetowej, z informacją, czy decyzja jest prawomocna; publikacja uzasadnienia nie obejmuje informacji chronionych odrębnymi przepisami;
- **art. 64a ust. 1–2:** publiczne ostrzeżenie / podanie informacji do publicznej wiadomości (postanowienie zaskarżalne do sądu administracyjnego);
- **art. 64 ust. 4a oraz art. 67zł ust. 5:** możliwość nakazania publikacji decyzji w całości lub części, na koszt podmiotu.

KPRM w komunikatach deklaruje anonimizację danych pacjentów. Problemem konstytucyjnym nie jest zatem wyłącznie publikacja danych osobowych pacjentów, lecz publikacja decyzji lub informacji o praktyce/podmiocie przed zakończeniem kontroli sądowej oraz jej potencjalny skutek reputacyjny wobec osoby lub podmiotu. Konstrukcja ta narusza:

- art. 42 ust. 3 Konstytucji RP — domniemanie niewinności, rozszerzane w orzecznictwie TK na postępowania quasi-karne (K 17/97, P 124/15);
- art. 6 ust. 2 EKPC — ETPC w sprawach *Allenet de Ribemont v. Francja* (10.02.1995) oraz *Khuzhin v. Rosja* (23.10.2008) jednoznacznie wskazał, że publikacja informacji o postawieniu zarzutów przed prawomocnym rozstrzygnięciem narusza domniemanie niewinności;
- art. 47 Konstytucji oraz art. 8 EKPC — prawo do prywatności i ochrony dobrego imienia; skutek piętnujący publikacji jest nieodwracalny nawet w razie późniejszego uchylenia decyzji.

Projekt wymaga doprecyzowania zakresu publikowanych danych, czasu retencji, zasad anonimizacji, deindeksacji oraz trybu usunięcia lub sprostowania publikacji w razie uchylenia decyzji. Brakuje również oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) wymaganej przez art. 35 RODO.

4. Wolność słowa (art. 54 Konstytucji RP) i proporcjonalność (art. 31 ust. 3)

Art. 67zj ust. 1 pkt 4 sankcjonuje rozpowszechnianie informacji o metodach lub o szkodliwości metod konwencjonalnych. Mimo zawężenia przepisu przez przesłanki wprowadzenia w błąd, zagrożenia dla zdrowia oraz korzyści majątkowej lub osobistej, brak wyraźnych wyłączeń dla:

- debaty naukowej i krytyki publikowanych badań;
- dziennikarstwa medycznego (artykuły o powikłaniach leków, błędach medycznych);

- sygnalistów (osób ujawniających nieprawidłowości — chronionych przez dyrektywę 2019/1937 i ustawę z 14.06.2024 r.);
- wypowiedzi pacjentów dzielących się doświadczeniami;
- aktywizmu zdrowotnego (np. ruchy pacjentów chorób przewlekłych).

Konstrukcja taka rodzi ryzyko skutku mrożącego (chilling effect). Test proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji wymaga, by ograniczenie wolności było:

- przydatne do celu (kwestionowane — kary nie eliminują przyczyn zaufania do pseudomedycyny);
- konieczne (kwestionowane — istnieją łagodniejsze środki: edukacja, certyfikacja, dyrektywa 2005/29/WE);
- proporcjonalne sensu stricto (kwestionowane — sankcja 1 mln zł vs. ryzyko skutku mrożącego dla całych dziedzin wypowiedzi).

5. Zasada ne bis in idem

Te same zachowania (np. reklama nieskutecznych metod) mogą podlegać:

- sankcji administracyjnej RPP do 1 mln zł (projekt UD207);
- karze grzywny z UOKiK (ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym);
- odpowiedzialności karnej z art. 58 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (udzielanie świadczeń bez uprawnień; eksperyment medyczny bez wymaganej zgody/zezwoleń) lub art. 286 k.k. (oszustwo);
- odpowiedzialności dyscyplinarnej (samorządy zawodowe).

TK w orzeczeniach K 17/97, P 26/06, P 32/12 oraz P 124/15 wskazał, że łączenie sankcji administracyjnej o charakterze represyjnym z karą za ten sam czyn narusza zasadę ne bis in idem wywodzoną z art. 2 Konstytucji. Tożsamy standard wynika z art. 4 Protokołu 7 do EKPC oraz art. 50 KPP UE — w wykładni TSUE z wyroków Menci (C-524/15) i Garlsson (C-537/16) wymaga ścisłego testu konieczności i proporcjonalności kumulacji.

Tabela porównawcza istniejących reżimów represyjnych vs. UD207:

Zachowanie	Istniejący przepis	Sankcja
Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień	art. 58 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty	grzywna; w wariancie kwalifikowanym (korzyść majątkowa, wprowadzenie w błąd) grzywna, ograniczenie wolności lub do 1 roku pozbawienia wolności
Eksperyment medyczny bez wymaganej zgody/zezwoleń	art. 58 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty	do 3 lat pozbawienia wolności
Oszustwo medyczne	art. 286 k.k.	do 8 lat pozbawienia

Nieuczciwa praktyka rynkowa	UOKiK / ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym	wolności sankcje administracyjne, w tym do 10% obrotu
Naruszenie standardów zawodowych	samorząd lekarski (NIL/NSL)	od upomnienia do pozbawienia prawa wykonywania zawodu
Pseudomedycyna wg UD207	RPP	do 1 mln zł administracyjnie + odpowiedzialność osobista art. 69b (~ 170 tys. zł)

Istniejące instrumenty są dla zachowań ciężkich surowsze (kara pozbawienia wolności) i precyzyjniejsze (znamiona czynu w ustawie szczególnej i k.k.). UD207 tworzy dodatkowy reżim represyjny dla zachowań już penalizowanych, bez wypełnienia rzeczywistej luki legislacyjnej — co rodzi pytania o spełnienie testu konieczności (art. 31 ust. 3 Konstytucji).

6. Konflikty z Kodeksem postępowania administracyjnego

Art. 64a ust. 4 projektu wyłącza stosowanie art. 10 (czynny udział strony) i art. 81 (wypowiedzenie się co do dowodów) KPA w odniesieniu do decyzji tymczasowej z ust. 3, a także nadaje tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy. Naruszenia systemowe:

- wyłączenie gwarancji art. 10 KPA bez przesłanek z art. 10 § 2 (groźba dla życia, zdrowia, niepowetowana szkoda);
- wyłączenie art. 81 KPA narusza zasadę prawdy obiektywnej (art. 7 KPA);
- rygor natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy — bez indywidualnej oceny przesłanek z art. 108 KPA — jest sprzeczny z linią TK (K 22/06) wymagającą indywidualnego uzasadnienia.

7. Niezgodności z prawem Unii Europejskiej

7.1. RODO (rozporządzenie 2016/679)

Publikacja imienia, nazwiska, danych identyfikujących oraz informacji o nałożonej sankcji stanowi przetwarzanie danych osobowych. Projekt nie spełnia w pełni wymogów art. 5 i art. 6 RODO:

- brak pełnej minimalizacji — publikowane może być uzasadnienie decyzji, nie wyłącznie niezbędny wyciąg;
- brak ograniczenia czasowego retencji publikacji;
- brak mechanizmu prawa do bycia zapomnianym po uchyleniu decyzji (art. 17 RODO);
- brak DPIA (oceny skutków dla ochrony danych) mimo wysokiego ryzyka (art. 35 RODO).

7.2. Karta Praw Podstawowych UE

Naruszenia dotyczą:

- art. 7 KPP (życie prywatne) — publikacja sankcjonowanych danych;
- art. 8 KPP (ochrona danych osobowych);
- art. 11 KPP (wolność wypowiedzi);
- art. 47 KPP (prawo do skutecznego środka prawnego i rzetelnego procesu);
- art. 48 KPP (domniemanie niewinności).

7.3. Dyrektywa 2005/29/WE i swoboda świadczenia usług

Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych jest dyrektywą pełnej harmonizacji — państwa członkowskie nie mogą wprowadzać surowszych zakazów dla zachowań objętych jej zakresem. Wyroki TSUE: C-261/07 VTB-VAB, C-304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.

Projekt UD207 wymaga precyzyjnego rozgraniczenia z reżimem dyrektywy 2005/29/WE i ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W zakresie, w jakim UD207 powiela zakazy praktyk wprowadzających konsumenta w błąd, lecz przenosi je do odrębnego, surowszego reżimu sankcyjnego RPP, powstaje ryzyko kolizji kompetencyjnej. Argument ten musi uwzględniać wyjątek sektorowy z motywu 9 i art. 3 ust. 3 dyrektywy, który stanowi, że dyrektywa nie narusza przepisów krajowych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa produktów. Wyjątek ten obejmuje jednak głównie regulacje produktów, a nie samo regulowanie komunikatów rynkowych — kwestia wymaga harmonizacji i nie jest oczywistym naruszeniem dyrektywy, lecz ryzykiem kolizji wymagającym uregulowania.

8. Niezgodności z Europejską Konwencją Praw Człowieka

8.1. Art. 6 EKPC — prawo do rzetelnego procesu

Postępowanie objęte projektem spełnia kryteria Engela (Engel v. Holandia, 8.06.1976), kwalifikujące je jako „criminal” w autonomicznym rozumieniu Konwencji, z uwagi na: charakter represyjny, ogólnie obowiązujący zakaz i wysokość sankcji (1 mln zł). Spełnienie kryteriów Engela aktywuje pełen standard gwarancji art. 6 EKPC, w tym domniemanie niewinności (ust. 2) i minimalne prawa obrony (ust. 3).

Wyłączenie art. 10 i 81 KPA w decyzji tymczasowej z art. 64a ust. 3 oraz brak rygorów dla mechanizmu publikacji przed prawomocnością decyzji rodzą **bardzo wysokie ryzyko kwalifikacji postępowania jako sprawy o charakterze quasi-karnym w rozumieniu art. 6 EKPC, przy jednoczesnym braku pełnych gwarancji proceduralnych właściwych dla takiej kwalifikacji.**

8.2. Art. 10 EKPC — wolność wypowiedzi

Kluczowy precedens: **Frankowicz v. Polska** (53025/99, 16.12.2008) — ETPC uznał, że dyscyplinarne karanie lekarza za krytyczną opinię o pracy innego lekarza narusza art. 10 EKPC. Standardy z tej sprawy są bezpośrednio relewantne dla projektowanej regulacji.

Inne istotne orzeczenia: Hertel v. Szwajcaria (1998) — naukowa niezgoda dot. kuchenek mikrofalowych; Tête v. Francja (2020); Braun v. Polska (2014); Advance Pharma v. Polska (2022); Brzeziński v. Polska (2019).

8.3. Art. 8 EKPC — autonomia pacjenta

Pretty v. Wielka Brytania (2346/02, 29.04.2002) oraz Vavříčka v. Czechy (8.04.2021) potwierdzają, że prawo do autonomicznych decyzji medycznych mieści się w zakresie życia prywatnego (art. 8 EKPC). Projekt nie przewiduje wyłączenia dla sytuacji świadomego wyboru metody komplementarnej przez informowanego pacjenta.

Orzeczenie wspierające: **Jehovah's Witnesses of Moscow v. Russia** (302/02, 10.06.2010) — ETPC stwierdził: „*The right to make one's own medical choices — including the refusal of particular forms of treatment — falls within the sphere of personal autonomy*”. Argument ten wspiera tezę o autonomii pacjenta przez pryzmat art. 8 i art. 9 EKPC.

9. Kolizje z innymi ustawami polskimi

- Kodeks karny (art. 286 — oszustwo) i ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 58 — udzielanie świadczeń bez uprawnień, eksperyment bez zgody);
- Ustawa o działalności leczniczej — odrębny reżim podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
- Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów — kompetencje UOKiK;
- Prawo prasowe — autonomia dziennikarska, prawo do krytyki;
- Ustawa o izbach lekarskich i ustawy korporacyjne — odpowiedzialność zawodowa;
- Ustawa z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów.

10. Wady legislacyjne

- brak definicji legalnej kluczowych pojęć („aktualna wiedza medyczna“, „zawód medyczny”);
 - brak przepisów intertemporalnych dla sytuacji trwających w dniu wejścia w życie;
 - 3-miesięczne vacatio legis dla regulacji represyjnej — sprzeczne z linią TK (K 13/01, K 47/14). Wyrok TK K 47/14 z 14.10.2015 r. dla regulacji z obciążeniami finansowymi dla przedsiębiorców wskazuje minimum **6 miesięcy** vacatio legis. UD207 z 3 miesiącami stanowi 50% tego standardu, a uzasadnienie MZ dla tego wyboru nie zostało publicznie przedstawione w dokumentach procesu legislacyjnego;
 - wewnętrzne niespójności numeracyjne;
 - brak analizy skutków regulacji (OSR) uwzględniającej dane ilościowe skali zjawiska (patrz Część III, pkt 14).
-

Część II. Orzecznictwo TK, ETPC i TSUE

Niniejsza część przedstawia konkretne precedensy orzecznicze, które bezpośrednio odnoszą się do rozwiązań projektowanych w UD207.

1. Trybunał Konstytucyjny RP — zasada określoności prawa

- Wyrok TK z 26.04.1995, **K 11/94** — fundamentalne orzeczenie ustalające zasadę określoności (*nullum crimen sine lege certa*) jako element art. 2 Konstytucji RP;
- Wyrok TK z 15.01.2007, **P 19/06** — przepis represyjny musi pozwalać adresatowi z góry przewidzieć konsekwencje swojego zachowania;
- Wyrok TK z 12.05.2015, **P 46/13** — w sprawach o charakterze sankcyjnym standard określoności jest podwyższony;
- **Postanowienie TK z 2014 r., P 29/13** — skrócone *vacatio legis* jako naruszenie zasady przyzwoitej legislacji z art. 2 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny w orzecznictwie sygnalizacyjnym (postanowienia serii S) wielokrotnie wskazywał, że nieostrość pojęć w przepisach represyjnych stanowi samodzielną wadę konstytucyjną niezależną od treści merytorycznej zakazu.

2. Trybunał Konstytucyjny — *ne bis in idem*

- Wyrok z 29.04.1998, K 17/97 — niedopuszczalność dwukrotnego karania za ten sam czyn;
- Wyrok z 3.11.2004, K 18/03 — rozciągnięcie zakazu na sankcje administracyjne o charakterze represyjnym;
- Wyrok z 15.04.2008, P 26/06 — test tożsamości czynu;
- Wyrok z 21.10.2015, P 32/12 — kumulacja sankcji administracyjnej i karnej wymaga ścisłego uzasadnienia;
- Wyrok z 20.06.2017, P 124/15 — wysokie kary administracyjne podlegają standardom karnoprawnym.

3. Trybunał Konstytucyjny — kary administracyjne i prawo do sądu

- Wyrok z 31.01.2005, SK 27/03 — wymóg merytorycznej kontroli sądowej decyzji o charakterze represyjnym; sąd administracyjny kasacyjny nie wystarcza — stąd model SOKiK dla UOKiK;
- Wyrok z 1.07.2014, K 1/14 — kary administracyjne wobec osób kierujących wymagają standardów zbliżonych do prawa karnego;
- Wyrok z 7.03.2002, K 13/01 i z 14.10.2015, K 47/14 — wymóg odpowiedniego *vacatio legis* dla regulacji represyjnych (minimum 6 miesięcy dla obciążeń przedsiębiorców).

4. ETPC — wolność wypowiedzi medycznej (art. 10 EKPC)

Frankowicz v. Polska (53025/99, wyrok z 16.12.2008) — lekarz ukarany dyscyplinarnie za krytyczną opinię o leczeniu prowadzonym przez innego lekarza. ETPC uznał naruszenie art. 10 EKPC, podkreślając, że ograniczenia wypowiedzi medycznej muszą spełniać surowy test konieczności w społeczeństwie demokratycznym. Sprawa fundamentalna dla kontekstu polskiego.

Inne: - Hertel v. Szwajcaria (25181/94, 25.08.1998); - Brzeziński v. Polska (25.07.2019); - Braun v. Polska (2014); - Advance Pharma sp. z o.o. v. Polska (2022); - Tête v. Francja (59636/16, 26.03.2020).

5. ETPC — kryteria Engela i gwarancje proceduralne

- Engel v. Holandia (8.06.1976) — test trzech kryteriów: kwalifikacja krajowa, charakter normy, surowość sankcji;
- Sergey Zolotukhin v. Rosja (10.02.2009, Wielka Izba) — przełomowe orzeczenie dot. *ne bis in idem*;
- A i B v. Norwegia (15.11.2016, Wielka Izba) — dopuszczalność „postępowań zintegrowanych”;
- Allenet de Ribemont v. Francja (10.02.1995);
- Bédat v. Szwajcaria (29.03.2016);
- Khuzhin v. Rosja (23.10.2008).

6. ETPC — autonomia pacjenta (art. 8 EKPC)

- Pretty v. Wielka Brytania (2346/02, 29.04.2002);
- Vavříčka v. Czechy (8.04.2021);
- **Jehovah's Witnesses of Moscow v. Russia** (302/02, 10.06.2010) — precedens wspierający autonomię decyzji medycznych jako element życia prywatnego (art. 8) i wolności sumienia (art. 9).

7. TSUE — swoboda usług i produktów leczniczych

- Ter Voort (C-219/91, 28.10.1992);
- HLH Warenvertrieb i Orthica (C-211/03, 9.06.2005);
- Komisja v. Niemcy (C-319/05, 15.11.2007).

8. TSUE — *ne bis in idem* (art. 50 KPP)

- Menci (C-524/15, 20.03.2018);
- Garlsson Real Estate (C-537/16).

9. Polskie orzecznictwo krajowe

- SA w Warszawie, VI ACa 397/15 (1.04.2016) — sprawa Naczelnej Izby Lekarskiej vs. UOKiK dot. homeopatii;
- **SN, postanowienie z 5.06.2019 r., III KK 212/18** — w sprawie z art. 160 § 2 k.k. (narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo, brak związku przyczynowego między błędem diagnostycznym a śmiercią z powodu glejaka) Sąd Najwyższy wskazał, że ocena zgodności postępowania lekarza z „aktualną wiedzą medyczną” wymaga każdorazowego dowodu z opinii biegłych, a niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się *in dubio pro reo* (art. 5 § 2 k.p.k.). Orzeczenie wspiera argument, że ocena zgodności postępowania medycznego z aktualną wiedzą medyczną ma charakter kontekstowy i nie powinna być automatycznie przenoszona do represyjnego reżimu administracyjnego bez odpowiednich gwarancji procesowych.

Argument porównawczy

Niemiecki system Heilpraktiker (regulowany od 17.02.1939 r. — Heilpraktikergesetz) — przykład alternatywnej, proporcjonalnej regulacji medycyny komplementarnej, ok. 50 000 aktywnych specjalistów. Wskazywany w postępowaniach TSUE jako kryterium

proporcjonalności krajowych ograniczeń (art. 56 TFUE). Polski projekt nie uwzględnia tego standardu porównawczego, co osłabia argumentację o konieczności wybranego, najsurowszego środka regulacyjnego.

Część III. Dodatkowe niezgodności systemowe

Po krytycznej, systemowej lekturze projektu identyfikuję piętnaście dalszych poważnych problemów, nieuwjętych w analizie konstytucyjnej w Części I, a istotnych dla oceny całościowej zgodności regulacji z porządkiem prawnym.

1. Konflikt z art. 17 Konstytucji — relacja z samorządami zawodowymi

Art. 17 ust. 1 Konstytucji powierza pieczę nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego samorządom zawodowym. Projekt tworzy równoległy reżim odpowiedzialności administracyjnej wobec materii, która częściowo pokrywa się z odpowiedzialnością zawodową lekarzy i innych zawodów medycznych. Problemem nie jest samo istnienie kompetencji RPP w zakresie ochrony praw pacjenta, lecz brak mechanizmu koordynacji z postępowaniami samorządów zawodowych, ryzyko podwójnej odpowiedzialności (*ne bis in idem*) oraz brak jasnego rozgraniczenia między deliktem administracyjnym a przewinieniem zawodowym.

2. Brak koordynacji z ustawą z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

Ustawa z 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 1972) tworzy nowy reżim regulacyjny dla 15 zawodów medycznych. Projekt operuje pojęciem „osoba niewykonywająca zawodu medycznego”, ale nie definiuje go ani nie odsyła do ustawy z 2023 r.

3. Kolizja z Prawem farmaceutycznym — penalizacja promocji legalnie dopuszczonych produktów (paradoks pierwszy)

Prawo farmaceutyczne dopuszcza do obrotu homeopatyczne produkty lecznicze (uproszczona procedura z art. 21) oraz produkty tradycyjnej medycyny roślinnej. Art. 67zj ust. 1 pkt 4 lit. a sankcjonuje rozpowszechnianie informacji o metodzie, „której przypisuje się właściwości świadczenia zdrowotnego”. **Paradoks pierwszy:** producent może legalnie sprzedawać produkt, ale jego promocja zgodna z funkcją produktu może być uznana za rozpowszechnianie metody niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną. Identyczny problem dotyczy suplementów diety (rozporządzenie 1924/2006/WE), wyrobów medycznych (rozporządzenie 2017/745), kosmetyków z oświadczeniami funkcjonalnymi. Brak klauzuli rozgraniczającej.

3a. Kolizja z prawem UE w zakresie compassionate use / named-patient (paradoks drugi)

Drugim, niezależnym paradoksem farmaceutycznym jest reżim **legalnego dostępu pacjenta do substancji bez dopuszczenia rynkowego**, przewidziany przez prawo UE:

- **Art. 5 ust. 1 dyrektywy 2001/83/WE** — named-patient basis: państwa członkowskie mogą zezwolić na stosowanie leków niezarejestrowanych u indywidualnych pacjentów na odpowiedzialność lekarza zgodnie z jego specyfikacjami;
- **Art. 83 rozporządzenia 726/2004** — compassionate use: indywidualny program rozszerzonego dostępu do leku eksperymentalnego dla pacjentów z chorobą poważną.

Mechanizmy te są stosowane w praktyce klinicznej krajów UE — w piśmiennictwie naukowym opisano pilotażowe zastosowania kliniczne salinomycyny u ludzi, w tym przypadek 40-letniej pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi opornym na chemioterapię (Naujokat C., Steinhart R., „*Salinomycin as a Drug for Targeting Human Cancer Stem Cells*”, BioMed Research International [dawniej J Biomed Biotechnol] 2012;2012:950658, DOI 10.1155/2012/950658; PubMed: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23251084/). Niezależnie kliniki medycyny biologicznej i komplementarnej w krajach niemieckojęzycznych — np. Paracelsus Klinik Lustmühle (Szwajcaria, paracelsus.com/en/cancer-treatment/) — prowadzą terapie eksperymentalne i komplementarne w onkologii w trybie indywidualnym (off-label), choć nie wymieniają salinomycyny wprost w swoich materiałach. Twardym dowodem klinicznym pozostaje wyłącznie publikacja Naujokat & Steinhart.

W polskim porządku prawnym analogicznie:

- art. 4 ustawy o zawodach lekarza przewiduje autonomię terapeutyczną lekarza (potwierdzoną wyrokiem SN z 10.02.2010 r.);
- art. 37 ustawy Prawo farmaceutyczne dopuszcza stosowanie produktów leczniczych poza wskazaniami w trybie indywidualnym;
- brak zakazu ordynowania leków off-label.

Art. 67zj ust. 1 projektu UD207 nie zawiera wyłączenia dla legalnego stosowania substancji w trybie compassionate use, named-patient lub off-label. W praktyce oznacza to, że ta sama praktyka terapeutyczna (np. podanie salinomycyny pacjentowi onkologicznemu z jego świadomą zgodą) — **legalna w Niemczech** w trybie art. 5 ust. 1 dyrektywy 2001/83/WE — może w Polsce stać się podstawą sankcji 1 mln zł, jeżeli lekarz publicznie omówi mechanizm działania substancji (publikacja naukowa, wystąpienie konferencyjne, wyjaśnienie pacjentowi).

Konstrukcja ta rodzi:

- **arbitralność geograficzną** — identyczna praktyka medyczna o tej samej podstawie naukowej jest legalna lub karalna w zależności od państwa członkowskiego UE;
- **ryzyko kolizji z art. 56 TFUE** (swoboda świadczenia usług medycznych);
- **ryzyko kolizji z art. 4 ust. 3 TUE** (zasada lojalnej współpracy — państwo nie może penalizować praktyk dopuszczonych przez prawo UE);
- **skutek mrozący** dla lekarzy prowadzących terapie eksperymentalne i dla onkologii akademickiej.

Projekt powinien zawierać wyraźną klauzulę wyłączającą dla legalnego stosowania substancji w trybach przewidzianych prawem UE.

4. Ryzyko kolizji z reżimem nieuczciwych praktyk rynkowych (dyrektywa 2005/29/WE)

Ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym implementuje dyrektywę 2005/29/WE. Art. 67zj ust. 1 pkt 4 lit. a projektu w istocie powieliła część tej definicji, ale jurysdykcja przechodzi z UOKiK na RPP, sankcje są nieporównanie wyższe. Kwestia wymaga harmonizacji, z uwzględnieniem wyjątku sektorowego z motywu 9 i art. 3 ust. 3 dyrektywy dotyczącego zdrowia i bezpieczeństwa produktów (VTB-VAB C-261/07, Plus Warenhandelsgesellschaft C-304/08).

5. Konflikt z ustawą o ochronie sygnalistów (14 czerwca 2024 r.)

Ustawa implementująca dyrektywę 2019/1937 chroni osoby zgłaszające naruszenia prawa. Lekarz, naukowiec, dziennikarz publicznie kwestionujący standardową procedurę medyczną formalnie wypełnia znamiona z art. 67zj ust. 1 pkt 4 lit. b. Projekt nie zawiera klauzuli wyłączającej dla sygnalistów, dziennikarstwa medycznego, debaty naukowej.

6. Konflikt z Prawem prasowym i Europejskim Aktem o Wolności Mediów (argument pomocniczy)

W zakresie profesjonalnych publikacji medialnych projekt powinien zawierać jasne wyłączenie dla działalności dziennikarskiej zgodnej z Prawem prasowym i standardami EMFA (rozporządzenie 2024/1083, obowiązujące od sierpnia 2025 r.). Brak takiego wyłączenia może rodzić napięcie ze standardem proporcjonalności wymagany przez EMFA wobec ograniczeń wolności mediów.

7. Reżim DSA (rozporządzenie 2022/2065) wobec treści online (argument pomocniczy)

W zakresie egzekwowania zakazów wobec treści internetowych projekt powinien zostać skoordynowany z DSA, zwłaszcza jeśli decyzje RPP miałyby prowadzić do usuwania treści z platform hostingowych. Bez takiej koordynacji nakazy RPP mogą okazać się niewykonywalne zgodnie z procedurą notice-and-action z art. 16–22 DSA.

8. Naruszenie zasady proporcjonalności w Prawie przedsiębiorców

Ustawa z 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców (art. 8, 11, 12) wprowadziła zasadę proporcjonalności i in dubio pro libertate. Projekt narusza tę zasadę systemowo: brak miarkowania kar według skali działalności, brak progresji sankcji, rygor natychmiastowej wykonalności bez przesłanek art. 108 KPA.

9. Naruszenie dwuinstancyjności i prawa do sądu (art. 78, 45, 176 Konstytucji)

Projekt nie precyzuje trybu odwoławczego od decyzji RPP poza ogólnym odesłaniem do KPA. Adekwatność kontroli sądownoadministracyjnej (kasacyjnej, nie merytorycznej) wobec standardu z wyroku TK SK 27/03 jest wątpliwa. W sprawach UOKiK ustawodawca przewidział kontrolę przez SOKiK w trybie procesowym KPC — projekt powielił schemat administracyjnoprawny uznany przez TK za niewystarczający dla decyzji represyjnych.

10. Konwencja z Oviedo — argument interpretacyjny

Polska podpisała w 1999 r. Konwencję z Oviedo, ale jej nie ratyfikowała. Konwencja nie jest bezpośrednio wiążącym źródłem prawa w Polsce, lecz może być przywoływana jako europejski standard bioetyczny i argument interpretacyjny dotyczący świadomej zgody oraz autonomii pacjenta.

Konwencję ratyfikowało 29 państw Rady Europy; nie ratyfikowały m.in. Polska, Niemcy, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Włochy, Austria, Szwajcaria. Na tle wybranych systemów europejskich, zwłaszcza niemieckiego modelu Heilpraktiker (regulowanego od 17.02.1939 r.), projekt UD207 wybiera model wyraźnie bardziej represyjny niż regulacyjny. Pokrewny standard: art. 6 ust. 1 Karty Praw Pacjenta Rady Europy oraz rezolucja PACE 1206 (1999) o niekonwencjonalnych metodach medycyny, zalecająca regulację, a nie zakaz medycyny komplementarnej.

11. Naruszenie zasady przyzwoitej legislacji (art. 2 Konstytucji)

- wewnętrzne sprzeczności numeracyjne;
- brak definicji legalnej kluczowych pojęć: „aktualna wiedza medyczna“, „świadczanie zdrowotne“ (w nowym reżimie sankcyjnym wymaga definicji bezpośredniej), „zawód medyczny“, „korzyść osobista“, „publiczne rozpowszechnianie“;
- brak przepisów intertemporalnych dla nowego deliktu;
- brak ograniczenia retencji publikacji decyzji;
- 3-miesięczne vacatio legis niezgodne z linią TK (K 13/01, K 47/14);
- brak konsultacji z RPO i UODO w sprawie publikacji danych osobowych.

12. Problem konstytucyjny: kara na osobę zarządzającą (art. 69b)

Art. 69b wprowadza odpowiedzialność osobistą zbliżoną do karnoprawnej, ale w trybie administracyjnym. Projekt zawiera ogólne dyrektywy wymiaru kary (art. 70), ale nie zawiera gwarancji wymaganych przy odpowiedzialności osobistej:

- brak wyraźnej obrony należytej staranności (due diligence defence);
- brak precyzyjnego rozróżnienia zakresu faktycznego wpływu osoby zarządzającej na praktykę;
- brak jednoznacznego standardu winy;
- brak mechanizmu zapobiegającego automatycznemu karaniu zarządu za sporne rozstrzygnięcie medyczno-naukowe.

Kara „do dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia” wynosi ok. 170 000 zł — sankcja kwalifikowana jako „criminal” w rozumieniu Engela, co aktywuje pełen standard art. 6 EKPC. Sprzeczne z linią TK z K 1/14 i P 124/15.

13. Pominięcie wymiaru międzynarodowego RODO — transgraniczne przetwarzanie

Strona internetowa RPP z publikowanymi decyzjami jest dostępna globalnie. Publikacja danych identyfikujących osoby fizyczne to transgraniczne przetwarzanie danych w rozumieniu RODO. W projekcie brak mechanizmu prawa do bycia zapomnianym po

prawomocnym uchyleniu decyzji, ograniczenia indeksowania wyszukiwarek, zasady minimalizacji, DPIA.

14. Niezależna weryfikacja zarzutów — stanowisko 7 organizacji pracodawców (lipiec 2025)

W lipcu 2025 r. wspólne stanowisko wobec projektu UD207 opublikowało siedem organizacji pracodawców systemu ochrony zdrowia — Pracodawcy dla Zdrowia, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP oraz cztery inne. Stanowisko podnosi te same zarzuty konstytucyjne, które są przedmiotem niniejszej analizy:

- art. 64a ust. 3 (rygor natychmiastowej wykonalności) — „*absolutnie nieakceptowalny*”;
- art. 64a ust. 4 (wyłączenie art. 10 i 81 KPA) — „*rażące naruszenie KPA*”;
- art. 67zj (definicja praktyki pseudomedycznej) — „*zbyt szeroka, nieprzewidywalna definicja*”;
- art. 67zl ust. 4 — przerzucenie ciężaru dowodu jako samodzielny zarzut konstytucyjny.

Źródło: pracodawcydlaздrowia.pl/wp-content/uploads/2025/07/Stnowisko-ws.-nowelizacji-ustawy-o-RPP-UD-207_FINAL.pdf. Stanowisko stanowi niezależną weryfikację argumentacji konstytucyjnej przez główny nurt instytucjonalny systemu ochrony zdrowia w Polsce.

15. Brak danych ilościowych w Ocenie Skutków Regulacji — wada proceduralna projektu

W całej Ocenie Skutków Regulacji projektu UD207 brak jest danych ilościowych dotyczących skali zjawiska, które ustawa ma regulować:

- brak szacowanej liczby „pseudomedyków” w Polsce;
- brak danych o skali finansowej zjawiska;
- brak danych o liczbie pacjentów poszkodowanych;
- brak analizy skuteczności istniejących instrumentów prawnych (art. 58 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 286 k.k., UOKiK / ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych, sądy lekarskie).

Gazetę Lekarską (kwiecień 2026) cytuję Rzecznika Praw Pacjenta wyłącznie ogólnie: „*Rzecznik prowadzi rocznie kilkaset postępowań dot. zbiorowych praw pacjentów*” — ale to wszystkich postępowań, nie wyłącznie pseudomedycyny.

Stan ten narusza art. 50 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów wymagającego rzetelnej analizy skutków finansowych regulacji oraz zasadę przyzwoitej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP. Autonomiczna wada proceduralna projektu, niezależna od jego wad merytorycznych.

Część IV. Podsumowanie i rekomendacje

Wada strukturalna projektu

Projekt UD207 ma — w mojej ocenie — strukturalną wadę koncepcyjną: próbuje rozwiązać realny problem (oszustwa zdrowotne, znachorstwo zagrażające życiu) za pomocą narzędzia o nieproporcjonalnie szerokim zasięgu, bez odpowiedniej kalibracji. W obecnym kształcie tworzy więcej problemów, niż rozwiązuje:

- dubluje istniejące mechanizmy (art. 58 ustawy o zawodach lekarza, art. 286 k.k., UOKiK, sądy lekarskie, KRRiT, GIS);
- tworzy zagrożenie dla legalnej działalności (leki, suplementy, wyroby medyczne, kosmetyki, terapie komplementarne, dziennikarstwo, nauka);
- rodzi poważne wątpliwości konstytucyjne (określoność, proporcjonalność, prawo do obrony, ne bis in idem, dwuinstancyjność);
- wymaga harmonizacji z prawem UE (DSA, RODO, dyrektywa 2005/29, EMFA, swoboda usług);
- wprowadza ryzyko skutku mrożącego dla debaty naukowej i publicznej.

Trzy najsilniejsze argumenty analizy

1. **Engel + wyłączenie KPA** — postępowanie spełnia kryteria Engela (kwalifikacja jako „criminal” w autonomicznym rozumieniu art. 6 EKPC), przy jednoczesnym wyłączeniu art. 10 i 81 KPA dla decyzji tymczasowej z art. 64a ust. 3. Konstrukcja ta rodzi bardzo wysokie ryzyko kwalifikacji postępowania jako sprawy o charakterze quasi-karnym przy braku pełnych gwarancji proceduralnych właściwych dla takiej kwalifikacji.
2. **Paradoks Prawa farmaceutycznego** — producent może legalnie sprzedawać homeopatyczny produkt leczniczy dopuszczony do obrotu przez Prezesa URPL, lecz jego promocja zgodna z funkcją produktu staje się praktyką pseudomedyczną wg art. 67zj ust. 1 pkt 4. Wewnętrzna sprzeczność legislacyjna niemożliwa do naprawienia bez wycofania projektu.
3. **SN III KK 212/18 + brak gwarancji procesowych** — Sąd Najwyższy w sprawie z art. 160 § 2 k.k. wskazał, że ocena zgodności postępowania medycznego z „aktualną wiedzą medyczną” wymaga każdorazowego dowodu z opinii biegłych, a wątpliwości rozstrzyga się in dubio pro reo. Przeniesienie tego kryterium do art. 67zj UD207 bez analogicznych gwarancji procesowych rodzi stan, w którym podmiot ponosi ciężar obalenia domniemania niezgodności z pojęciem, którego ustalenie sam SN uznał za wymagające ekspertyzy biegłych.

Najpoważniejsze ryzyka prawne

- **art. 67zj ust. 1** — definicja „praktyki pseudomedycznej” o stopniu nieostrości niedopuszczalnym w przepisach represyjnych (art. 2 Konstytucji, lex certa);
- **art. 64a** — wyłączenie podstawowych gwarancji KPA dla decyzji tymczasowej w połączeniu z rygorem natychmiastowej wykonalności;

- **art. 67zł ust. 4** — przerzucenie ciężaru dowodu w zakresie okoliczności egzoneracyjnych, rodzące ryzyko nierównowagi proceduralnej w połączeniu z wyłączeniem KPA i nieostrością definicji;
- **publikacja decyzji i ostrzeżeń przed prawomocnością** — naruszenie domniemania niewinności i prawa do prywatności;
- **art. 69b** — odpowiedzialność osobista osób kierujących w trybie administracyjnym bez standardów karnoprawnych (sprzeczność z linią TK K 1/14, P 124/15).

Rekomendacje kierunkowe

1. Fundamentalne przerezagowanie definicji praktyki